

福建省医疗保障管理委员会办公室文件

闽医保办〔2017〕73号

福建省医疗保障管理委员会办公室关于调整 省属公立医院普通门诊诊查费等 项目价格的通知

各设区市医疗保障管理局、平潭综合实验区医疗保障管理局，各省属公立医院、福州总医院：

根据国家发展改革委等四部委《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》（发改价格〔2016〕1431号）、国家卫生计生委等六部委《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发〈关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见〉的通知》（闽委办发〔2016〕44号）和《福建省推进医

疗服务价格改革实施方案》（闽医保办〔2017〕35号）等文件精神，为进一步体现医务人员技术劳务价值，逐步理顺医疗服务比价关系，不断优化医院收入结构，促进医疗机构规范诊疗行为，经研究，决定对省属公立医院普通门诊诊查费、门急诊留观诊查费、便民门诊等项目价格进行调整。现将有关事项通知如下：

一、普通门诊诊查费项目内涵：是指相应级别的医师提供的普通门诊诊疗服务，含初建病历（电子或纸质病历），核实就诊者信息，听取主诉，采集病史，进行一般物理检查，简要地向患者或家属告知病情，开具检查单，做出门诊诊断，根据病情提供治疗方案（治疗单、处方），并按规范书写门诊病历等。

二、调整后的普通门诊诊查费、门急诊留观诊查费、便民门诊等项目价格情况详见下表：

项目名称	计价单位	三甲医院			三甲以下医院		
		调整前价格（元）	调整后价格（元）	提高部分职工医保统筹基金报销（元）	调整前价格（元）	调整后价格（元）	提高部分职工医保统筹基金报销（元）
普通门诊诊查费							
普通门诊诊查费-主任医师	次	25	50	25	20	45	25
普通门诊诊查费-副主任医师	次	20	40	20	16	35	19
普通门诊诊查费-主治医师	次	12	30	18	11	25	14
普通门诊诊查费-住院医师	次	12	30	18	11	25	14
门急诊留观诊查费	日	20	45	25	20	45	25
诊查费-便民门诊	次	6	12	3	6	12	3

三、调整后的普通门诊诊查费、门急诊留观诊查费、便民门

诊，原收费标准的部分保持医保支付政策不变，提高的部分普通门诊诊查费、门急诊留观诊查费职工医保由统筹基金统一支付，便民门诊提高的部分职工医保由统筹基金统一支付 3 元。各统筹区按规定转诊到省属公立医院就诊的参保患者，其医保统筹基金支付标准由各统筹区另行制定，同步实施。省本级参保对象到各设市医疗机构就诊，普通门诊诊查费、门急诊留观诊查费和便民门诊按照就医地医保支付政策执行。

四、患者同一天由同一位医师多次诊治的，只收取一次诊查费。门诊特殊病种慢性病患者，在门诊就诊时医师可视病情适当延长门诊处方用量，一次可开具 2 个月的处方用量，方便慢病患者就医治疗。

五、三级甲等医院和三级儿童专科医院普通门诊诊查费 6 岁及以下儿童实行加收政策，其中：主任医师加收 5 元，副主任及以下医师加收 3 元。

六、调整普通门诊诊查费等体现医务人员技术劳务价值的项目价格，是推进医疗服务价格改革，优化医疗机构收费结构，加快推进分级诊疗制度建设的一项重要措施。各省属公立医院要充分认识此次价格调整改革的重要意义，强化医疗费用控制，努力降低检查化验收入占比、卫生材料收入占比、门诊人次人头比等控费指标，采取有效措施，进一步规范诊疗行为，重点防范违规刷卡等行为。

七、各设区市医疗保障部门要结合本地区实际，按照“腾空间、调结构、保衔接”的要求，充分评估本地区基金的配套能力

及患者负担情况，统筹考虑本辖区内公立医院普通门诊诊查费等项目的调整工作，确保价格调整平稳实施。城镇职工医保未开展普通门诊统筹的地区，务必谨慎对待价格调整工作。对具备基金配套能力及控费工作开展较好的设区市，要按照“四个拉开”的要求，进一步拉开省、市、县公立医院普通门诊诊查费等项目的价格差距，合理确定价格并跟进医保配套政策，促进分级诊疗。各地拟定的价格及医保配套方案需报我办审核平衡后实施。

八、合理制定基层医疗卫生机构（不含村卫生所、社区卫生服务站）普通门诊诊查费价格，同步落实医保报销政策。基层医疗卫生机构普通门诊诊查费要与县级公立医院普通门诊诊查费拉开差距，利用价格与医保支付政策促进患者合理就医。

本通知自 2017 年 9 月 12 日起执行。以前有关规定与本通知不符的，以本通知规定为准。



信息公开类型：主动公开

抄送：国家发展改革委价格司，省政府办公厅、省医改办、省卫计委

福建省医疗保障管理委员会办公室

2017 年 8 月 22 日印发